

إِسْمُ الْمَرِيضِ رِبَاعِيًّا : هَدَى شَحَاتَهُ هَلَالَ إِمَام

الحي / المدينة : البدرشين

المحافضة : الجيزه

رقم البطاقة : 28709012104787 رقم التلفون : 01091569600

العمر (تاريخ الميلاد) : 01-09-1987 المهنة : لاتعمل

أقر انا الموقع أدناه انني لا اتمتع باي نظام علاج مثل:- التأمين الصحي-القوات المسلحة-الشرطة-
الهيئات-المؤسسات او اي نظام يتعارض مع نظام العلاج علي نفقة الدولة- وسوف اتحمل كافة
نفقات العلاج في حالة ثبوت غير ذلك

الإخصائي الاجتماعي (-----) التوقيع: (-----)

المقرر بما فيه التوقيع: (-----)

التشخيص الإكلينيكي : سرطان بالثدي (مبادرة)

نتائج الأبحاث : (مرفق)

التشخيص النهائي : سرطان بالثدي (مبادرة)

خطة العلاج : أبحاث أورام ماموجرام وسونار علي الثديين [10888] **قسم العلاج :** الاورام

----- التعليق على التشخيص :

GR1-E
جورستان
روستای پلانی
لندی حسن
موسین رمضان
صحة البیابان المرفقة
للجنة و مدین

الاسم: د/محمد کیلانی

الاسم: د/ندی حسن

الاسم: د/نرمين رمضان

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

الوظيفة: ----- التوقيع:

تتعمد صحة البيانات المرفقة
رئيس اللجنة و مدير
المستشفى.

أطلعت اللجنة علي لائحة العلاج الخاصة بالمجالس وتلتزم جهة العلاج بلائحة المجالس الطبية.

كما تقر اللجنة بأن البيانات المدونة في هذا النموذج صحيحة.

تتعهد المستشفى أن لا يتم تنفيذ القرار إلا بعد مراجعة الملف الطبي للمريض وإعادة مناظرة المريض بالمستشفى قبل الصرف.

----- / د ----- / د ----- / د. | ----- / د. |

قرار اللجنة

التشخيص النهائي :

خطة العلاج :

المستشفى :

جهة العلاج : --

ملاحظات : ---

ختم

شعار الجمهورية

مدير عام

مديرية الشئون الصحية

رئیس

المجلس الطبي المتخصص

--

Name: هدي شحاته هلال امام National ID: 28709012104787	
--	---

تقرير طبي

السيد
تحية طبية وبعد,,

إيماء للطلب المقدم من	بشأن تقرير طبي للمريض
بقسم:	رقم طبي:

نتشرف بان نوضح فيما يلي تقريرنا عن حالته
--

تاريخ وساعة الدخول : -- --:-- yyyy-mm-dd	تاريخ وساعة الخروج : PM 01:17 05-07-2026
---	---

وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه
--

المریضة تعاني من ورم غير حميد بالثدي و تحتاج الي Bilateral mammogram and breast ultrasound
--

التاريخ : 05-07-2026	الوقت : -- --:--
	الطبيب المعالج : د/شيماء لاشين





٢٠٢٢/٧
٢٨٧-٩٥ ١٢١٠٤٧٨٧
ربة منزل



أنتى
مسلمة
مروجة
احمد سعيد محمد سيد رمضان
٢٠٢٤/٧/٢٣

البطاقة سارية حتى



Name: هدى شحاته هليل امام		
MR. : 2845		
Detailed Medical Report		
		السيد
تخية طيبة وبعد,,		
	بشأن تقرير طبي للمريض	إيماء للطلب المقدم من
	رقم طبي:	بقسم:
ننشرف بأن نوضح فيما يلي تقريراً عن حالته		
	تاريخ وساعة الخروج :	تاريخ وساعة الدخول :
وبعد الكشف والفحوصات والمتابعة وجد انه		
The patient underwent neoadjuvant chemotherapy (NACTH) followed by radiotherapy and breast-conserving surgery (BCS) in 2023, with subsequent adjuvant therapy including tamoxifen and zoladex. The plan included a 12-month course of tamoxifen 20 mg daily, calcium, and vitamin D supplementation, with a switch to femara (letrozole) 1 mg daily and continued zoladex 0.8 mg subcutaneously. Endometrial evaluation revealed a 12 mm lesion, prompting discussion of definitive treatment and surgical consultation. On 18 February 2026, the patient underwent an endometrial biopsy, which was negative for malignancy. The patient was switched to femara 1 mg daily with calcium 1 g and zoladex 10.8 mg subcutaneously on 27 April 2026. A chest CT was ordered by pharmacy for further evaluation.		
تحريرا في ,		
	الوقت :	التاريخ : 21-09-2026
	الطبيب المعالج : ايه مدحت بدوي محمد	
يعتمد ,		



البرنامج الرئاسي لصحة المرأة
وزارة الصحة والسكان



1620



12/03/2024

0

Psychiatric

Nutrition

1450

[illegible]

PATIENT NAME: HUDA SHEHATA Hlayel EMAM
GENDER: Female
AGE: 35 y

PATIENT ID #: 10123230329
ORDER #: 2438396,2438397
DATE OF SERVICE: 14-Aug-2023 12:55 PM

Report: - all studies

**POST CONTRAST MULTI-SLICE CT SCAN OF THE CHEST,
ABDOMEN AND PELVIS**

1-CHEST

Given history of breast cancer patient.

- Right breast mass is seen measuring about 16 x 17 mm with adjacent small soft tissue nodule.
- Prominent right axillary lymph nodes.
- No sizable pulmonary nodules, masses, areas of consolidation or cavitory lesions.
- No CT evidence of pathologically enlarged hilar or mediastinal lymph nodes.
- No evidence of pleural effusion, pleural thickening or masses seen.
- Normal cardiac size and shape.
- No pericardial effusion detected.

2- ABDOMEN AND PELVIS

- The liver is of mildly enlarged showing right hepatic lobe (segment V) hypodense focal lesion is seen measuring about 7 x 12 mm. it shows peripheral nodular enhancement best appreciate in the portal phase and becomes iso-dense on the delayed phase.
 - Patent homogenously enhancing portal vein and its main branches as well as its main tributaries.
 - Right ovarian cyst is are seen measuring 29 x 41 mm, likely functional.
 - Normal appearance of the pancreas, spleen, kidneys, adrenals, aorta, and I.V.C.
 - Smooth filling of the urinary bladder with no filling defects or diverticular outpouching.
 - No pathologically enlarged abdominal or pelvic lymph nodes.
 - No abdominal or pelvic collections.
 - The revised bone window revealed:
1. No CT evidence of vertebral collapse or extra-osseous soft tissue component.